의료진 진료 카드 · ASL-005

젊은 고혈압 · 선별과 의뢰

연자 Q&A 중심 카드. 조절이 안 될 때까지 기다리지 않고 진단 확인·이차성 원인·장기 손상을 함께 평가한다.

연자 Q&A · 모든 젊은 환자가 즉시 의뢰 대상은 아니다



연자 Q&A · 의원에서 시행할 기본 평가

검사	혈청 칼륨·크레아티닌, 소변검사·uACR, 공복혈당·지질·갑상선기능·심전도, 혈장 알도스테론 농도·레닌 활성.
검사 시점	가능하면 약제 시작 전 채혈. 알도스테론/레닌 비(ARR)는 MRA를 제외한 대부분의 항고혈압제를 중단하지 않고 검사할 수 있다고 답변. 저칼륨혈증은 교정 후 검사.
치료 병행	치료를 미룰 필요는 없다. 진단 확인·기본 선별·장기 손상 평가·약물치료 시작은 대부분 의원에서 가능하다는 연자 답변.

연자 Q&A · 의뢰 조건

임상·선별 이상	저칼륨혈증·ARR 이상, 복부 잡음, 양팔 또는 상하지 혈압 차이, 발작성 두통·발한, 쿠싱 징후.
혈압·장기 손상	혈압 ≥160/100 mmHg 또는 3제에도 비조절, 좌심실비대·알부민뇨·eGFR 감소 등 장기 손상.

연자 Q&A: 젊은 성인 고혈압의 이차성 원인은 14~33%로 보고. 젊은 고혈압 선별(I, B), 조기 발병 고혈압의 일차성 알도스테론증 선별(I, C)을 설명했다.

의료진 진료 카드 · ASL-005

젊은 고혈압 · 진단 확인의 실제

본강의의 정확한 측정과 진료실 밖 혈압을 사용하고, 연자 Q&A의 원인별 의뢰 방향을 연결한다.

본강의 · 진료실·가정 측정

준비	측정 30분 전 흡연·음주·카페인 금지, 배뇨 후 최소 5분 안정. 연자는 환자에게 5~10분 또는 10분 안정을 교육한다고 설명.
자세·커프	등받이·발바닥 지지, 다리 꼬지 않기, 팔둘레에 맞는 커프를 심장 높이에. 대화·휴대폰 사용을 하지 않고 맥박 규칙성도 확인.
반복·기록	진료실은 ≥30초 간격 반복 평균. 본강의의 가정 측정 예: 아침·저녁 각 3회, 30초 간격, 외래 전 5~7일. 날짜·시간·수축기/이완기·맥박·측정 팔 기록.

본강의 · 진료실 밖 혈압으로 구분

진단 기준	진료실 ≥140/90 mmHg, 주간 활동·가정 ≥135/85 mmHg, 24시간 평균 ≥130/80 mmHg라는 강의 제시 기준.
백의·가면	진료실만 높으면 백의고혈압, 진료실 밖만 높으면 가면고혈압. 치료 중에는 백의 비조절·가면 비조절로 구분하여 약제를 조절한다.

연자 Q&A · 검사 방식과 의뢰 진료과

혈압계 선택

진단·야간혈압·dipping은 24시간 측정, 장기 추적은 검증된 위팔 가정혈압. 반지형 커프리스는 보조로 고려하되 치료 시작·중단 결정은 커프형으로 재확인.

의뢰 방향

일차성 알도스테론증 의심: 내분비내과·심장내과. 조절이 어려우면 검사와 약제 조정을 함께 의뢰. 신실질·신혈관 질환 의심: 신장내과.

연자 Q&A의 반복 측정 설명: 진료실 ≥30초 간격·≥2회 평균, 3회면 뒤 2회 평균을 사용. 가정은 1~2분 간격 2회·모든 값 기록으로 답변했다. 본강의의 30초 간격 3회 교육 예와 구분한다.